



• GUIA PARA A ENFERMAGEM

Nutrição do RN na **UTI** **Neonatal**

Leite materno, sonda e
nutrição parenteral

E os sinais de
enterocolite que
pedem ação.



Material gratuito

ITH Educação · Nota 5 no MEC



O primeiro leite é o da própria mãe

Para o Ministério da Saúde, o melhor leite para o RN pré-termo é o da própria mãe: digere melhor, traz componentes imunológicos únicos e há fortes evidências de que reduz a enterocolite. O leite de banco de leite humano é a segunda opção.

1

Ordenha cedo e com frequência

Estimular a mama e retirar leite de preferência nas primeiras 24h após o parto e, depois, de forma regular, a cada 3h. Contato pele a pele (Método Canguru) ajuda a manter a produção.

2

Técnica da ordenha (rBLH)

Mãos higienizadas, cabelo preso, massagem antes de ordenhar e primeiros jatos desprezados. Mamas limpas só com água, sem sabão ou cremes. Frasco estéril, rotulado com nome, data e hora.

Armazenamento e validade (RDC 171/2006 e rBLH)

Produto	Condição	Validade
Leite cru da mãe, refrigerado	Até 5 °C, fora da porta da geladeira	12 horas
Leite cru da mãe, congelado	-3 °C ou menos (RDC). A norma rBLH 18.21 pede -4 °C ou menos	15 dias da 1ª coleta
Leite pasteurizado do banco, congelado	-3 °C ou menos	6 meses
Leite pasteurizado após o degelo	Refrigerado até 5 °C	24 horas

O leite cru (sem pasteurizar) só pode ir da mãe para o próprio filho, com ordenha supervisionada em ambiente próprio. O degelo é feito em banho-maria a 40 °C, nunca em micro-ondas.

Colostroterapia

É o uso do colostro com fim imunológico, não nutricional, sobretudo no RN de muito baixo peso: gotas de colostro cru da mãe na mucosa orofaríngea, que podem ser dadas mesmo em jejum. A SBP a descreve como **proposta que ainda precisa de evidências** e pede norma escrita na unidade. A revisão Cochrane de 2018 (6 estudos, 335 RN) não mostrou diferença em enterocolite, infecção ou óbito, com evidência de certeza muito baixa.

Volume, frequência e duração da colostroterapia seguem o protocolo da sua unidade e a prescrição. Não há padrão nacional único.

Sonda no lugar certo, dieta no ritmo certo

No âmbito da equipe de enfermagem, a inserção de sonda oro ou nasogástrica é **privativa do enfermeiro** (Res. Cofen 619/2019). O técnico auxilia, cuida e registra.

OG

Oro x nasogástrica

A sonda nasal pode atrapalhar a respiração; a oral desloca mais e irrita. A Cochrane (2013) não achou dados suficientes para preferir uma via.

cm

Medida: NEMU

Nariz, lóbulo da orelha e ponto médio até o umbigo. Em estudo randomizado com 173 RN, a medida nariz-orelha-apêndice xifoide deixou mais sondas altas e não deve mais ser usada.

pH

Confirmação

Raio X é o padrão. pH do aspirado $\leq 5,5$ indica estômago (estudo brasileiro, 162 RN); acima disso, confirme por imagem. Ausculta não é confiável.

Dieta trófica e progressão (MS, Atenção à Saúde do RN, vol. 4)

- 1 Quando começar:** assim que o RN estiver hemodinamicamente estável e com peristalse, mesmo intubado ou com cateter umbilical. Evitar início precoce em asfixia ($\text{pH} < 7,1$), má perfusão ou uso de vasopressor.
- 2 Quanto:** o MS cita início com 10 a 20 mL/kg/dia de leite materno ou colostro e avanço de cerca de 20 mL/kg/dia no RN < 1.500 g. Avançar até 30 mL/kg/dia não aumentou o risco de enterocolite. O volume é sempre o da prescrição.
- 3 Como:** prefere-se a gavagem em bolo. Infusão contínua fica para esvaziamento gástrico lento, em **bomba de seringa na horizontal**: na bomba peristáltica a gordura do leite fica no equipo.

E o resíduo gástrico?

O que o manual de 2014 diz

Aumentar a dieta se não houver resíduo (menos de 20% a 30% do volume oferecido), distensão abdominal e se a peristalse estiver boa.

O que a Cochrane de 2023 achou

Medir o resíduo de rotina não preveniu enterocolite e atrasou a dieta plena em cerca de 3 dias, com mais dias de parenteral e mais infecção.

Na prática: siga o protocolo da unidade. Resíduo bilioso, com sangue, distensão ou piora clínica são sinais de alerta e vão para o médico na hora.

Parenteral: via exclusiva, bomba e luz

O enfermeiro é o responsável pela administração da NP (Portaria SVS/MS 272/1998, ainda a norma da Anvisa para terapia parenteral). O MS recomenda iniciar a NP do pré-termo nas primeiras 24h de vida.

Cuidado	O que a norma pede
Via	Periférica com glicose até 12,5%; central (inclusive PICC) até 25% (MS). Cofen 453/2014: periférica até 900 mOsm/L. Via exclusiva ; exceção só com aval da EMTN.
Recebimento	Conferir no rótulo nome, leite, composição, osmolaridade, volume, velocidade e validade. Com partícula, precipitado, cor alterada ou fases separadas, não instalar e devolver à farmácia.
Conservação	Geladeira exclusiva de medicamentos, 2 °C a 8 °C. Retirar antes para chegar à temperatura ambiente. Longe de fontes de calor.
Infusão	Contínua, em bomba adequada à idade. É vedado compensar volume em atraso ou infusão rápida. Filtro na linha é recomendado.
Luz	Evitar luz direta, com cuidado especial no RN em fototerapia. O MS cita cobrir frasco e equipos com material opaco.
Equipo	Anvisa (2017): trocar a cada bolsa de NP e a cada 12h na emulsão lipídica, ambos sem DEHP.
Glicemia	Capilar conforme rotina. O MS busca 60 a 120 mg/dL e sugere hiperglicemia acima de 145 mg/dL. Antes, descarte erro de bomba.

CÁLCULO RESOLVIDO

RN de 1,2 kg: dieta e parenteral (prescrição fictícia)

Dieta: leite materno 12 mL de 3/3h = $12 \times 8 = 96$ mL/dia ÷ 1,2 kg = **80 mL/kg/dia**

Oferta hídrica prescrita: 150 mL/kg/dia. Falta pela veia: $(150 - 80) \times 1,2 =$ **84 mL em 24h**

Velocidade da bomba: $84 \text{ mL} \div 24\text{h} =$ **3,5 mL/h**

Conferência da glicose a 10%: $84 \times 0,10 = 8,4 \text{ g} \div 1,2 \text{ kg} = 7 \text{ g/kg/dia} =$ **4,9 mg/kg/min**

Cálculo da ITH com números fictícios. A taxa fica dentro do início de 4 a 6 mg/kg/min citado pelo MS. Para comparar: uma trófica de 15 mL/kg/dia nesse RN seria 2,25 mL de 3/3h. Volumes reais vêm da prescrição e da EMTN.

Enterocolite: reconhecer cedo

Atinge 1% a 8% dos internados em UTI neonatal e 4% a 13% dos RN com menos de 1.500 g, com letalidade de 10% a 50% (MS). Raramente aparece antes de iniciar a dieta.

Estágio (Bell modificado)	O que se vê
IA e IB · suspeita	Temperatura instável, apneia, bradicardia, letargia, resíduo pré-gavagem, distensão leve, vômitos, sangue oculto (IA) ou vivo (IB) nas fezes
IIA e IIB · definida	Ruídos ausentes, dor abdominal, pneumatose no raio X. No IIB, acidose metabólica e plaquetas baixas
IIIA e IIIB · avançada	Hipotensão, peritonite, acidose mista, CIVD. No IIIB, pneumoperitônio (perfuração): cirurgia

Fatores de risco (MS)

Prematuridade, asfixia, cateter umbilical, avanço rápido da dieta, canal arterial, cardiopatia, policitemia, indometacina ou metilxantinas.

Na suspeita

Avisar o médico, suspender a dieta conforme conduta, sonda orogástrica aberta em drenagem, manter a NP e registrar abdome, fezes e resíduo.

FERRAMENTA PARA IMPRIMIR

Registro de dieta e balanço do turno

Hora	Dieta (tipo e mL)	Sonda (cm, conferida)	Abdome e resíduo	NP/EV (mL)	Diurese e fezes	Glicemia
Total		Peso:	Entradas:		Saídas:	Balanço:

Diurese esperada de 2 a 4 mL/kg/hora (MS). Registre também cor do resíduo e aspecto das fezes quando avaliados.

● FONTES E METODOLOGIA

De onde vêm as informações

Todas as fontes foram consultadas em 04/10/2026. O caso da página 4 usa prescrição fictícia e foi calculado pela ITH. Tabelas resumidas com nossas palavras.

- 01 **Ministério da Saúde. Atenção à Saúde do Recém-Nascido, vol. 4, 2ª ed. 2014: caps. 34, 35 e 37**
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_v4.pdf
- 02 **Anvisa. RDC nº 171/2006 (bancos de leite humano)**
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2006/res0171_04_09_2006.html
- 03 **rBLH/Fiocruz. Norma BLH-IFF/NT 18.21: pré-estocagem do leite humano ordenhado cru**
rblh.fiocruz.br
- 04 **rBLH/Fiocruz. Ordenha, manipulação e administração do leite cru da mãe para o próprio filho**
rblh.fiocruz.br
- 05 **SBP. O que é colostroterapia?**
sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/Colostroterapia.pdf
- 06 **Nasuf et al. Cochrane 2018: colostro orofaríngeo em pré-termos**
cochranelibrary.com (CD011921.pub2)
- 07 **Cofen. Resolução nº 619/2019 (sondagem oro/nasogástrica e nasoentérica)**
cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-619-2019
- 08 **Cofen. Resolução nº 453/2014 (enfermagem em terapia nutricional)**
cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-0453-2014
- 09 **Watson e McGuire. Cochrane 2013: via nasal x oral para sondas em pré-termos**
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23450546
- 10 **Cirgin Ellett et al. JOGNN 2011: medida de inserção da sonda gástrica em neonatos**
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21639864
- 11 **Dias et al. Rev. Latino-Am. Enfermagem 2019: fita de pH para sonda gástrica em RN**
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6896807
- 12 **Abiramalatha et al. Cochrane 2023: resíduo gástrico de rotina e enterocolite**
cochranelibrary.com (CD012937.pub3)
- 13 **Ministério da Saúde/SVS. Portaria nº 272/1998 (terapia de nutrição parenteral)**
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0272_08_04_1998.html
- 14 **Anvisa. Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, 2017**
gov.br/anvisa (caderno 4)

Ressalvas. Volumes, velocidades e soluções vêm sempre da prescrição médica e da EMTN. O manual do MS é de 2014; quando há evidência mais nova (resíduo gástrico, colostroterapia), o guia mostra as duas posições. Protocolos institucionais prevalecem.



• PARA IR ALÉM

Quer segurança para cuidar do RN mais grave?

Dieta, parenteral e sinais de enterocolite fazem parte de cada plantão na UTI neonatal. A Pós em UTI Neonatal e Pediátrica da ITH tem simulação realística em laboratório de PICC, ventilação mecânica e urgência neopediátrica.

Pós-graduação em UTI Neonatal e Pediátrica

- ✓ Simulação realística em laboratório
- ✓ PICC, ventilação mecânica e urgência neopediátrica
- ✓ 440h, formato híbrido, turmas em Goiânia e Brasília
- ✓ Diploma reconhecido pelo MEC (ITH, conceito 5)

[Quero conhecer a pós](#)mkt.faculdadeith.com.br/lp/uti-neonatal-pediatria-captura/

Resumo em 30 segundos

12 h

validade do leite cru da mãe na geladeira, até 5 °C

15 dias

validade do leite cru congelado, a partir da 1ª coleta

pH ≤ 5,5

no aspirado indica sonda no estômago

4% a 13%

dos RN < 1.500 g têm enterocolite (MS)